Le triage et la file d'attente

Du moment où le patient décrit ses symptômes jusqu'à son tour chez le médecin. MediConnect · module Gestion patient

1 · LE TRIAGE : QUEL NIVEAU D'URGENCE ?

Le patient décrit

- symptômes cochés (catalogue)
- constantes (température…)
- 4 échelles de 0 à 5 : douleur, fièvre, respiration, état général
- **texte libre** : « décrivez ce que vous ressentez »

›

① Règles pondérées

Pas d'IA : calcul prévisible

Points = symptômes + constantes + échelles

≥ 20 points → 2
≥ 12 points → 3
≥ 5 points → 4
moins → 5

Un **signe d'alerte** impose un niveau minimal : le plus urgent l'emporte.

›

② Modèle de lecture du texte

Apprentissage automatique, sur le serveur

Lit le texte libre, estime un niveau et sa confiance.

Relève le niveau si confiance ≥ **85 %**.

Jamais de baisse. Jamais le niveau vital.

+

③ IA Groq (facultative)

Si le patient l'a accepté

Repère dans le texte des symptômes non cochés, avec citation vérifiée. Ne décide jamais d'un niveau.

›

Niveau final

1 **Vital**
2 **Très urgent**
3 **Urgent**
4 **Standard**
5 **Non urgent**

Le médecin peut requalifier.

2 · LA FILE D'ATTENTE : DANS QUEL ORDRE PASSE-T-ON ?

Un délai cible par niveau

en minutes de **présence du médecin** (pas de « retard » la nuit)

2	**Très urgent**	**30 min**
3	**Urgent**	**2 h**
4	**Standard**	**8 h**
5	**Non urgent**	**1 jour de présence**

Échéance = heure de la demande + délai.

›

Tri par groupes, puis par échéance

0 **Cas vital** (niveau 1)
1 **Garantie** : demande protégée qui a attendu ≥ 3 × son délai
2 **Niveaux 2 et 3** (urgents)
3 **Demandes protégées** de niveau 4 et 5
4 Toutes les autres : les plus anciennes d'abord

›

Personne n'attend sans fin

Chaque fois qu'une demande plus récente passe devant, un **dépassement** est compté.

Après **5 dépassements**, la demande est **protégée** : seuls les niveaux 1 à 3 peuvent encore passer devant elle.

Après 3 × son délai, elle passe même devant les urgents (sauf le vital).

›

Ce que voit le patient

Dans les temps | **À risque** ≥ 75 % du délai | **En retard**

Sa place dans la file ou son heure fixée, son **heure prévue** (calculée dans l'agenda, partie 3), une jauge du délai.

3 · L'AGENDA DU MÉDECIN : L'HEURE PRÉVUE DE CHACUN, ET LES E-MAILS

Deux façons d'avoir une heure

Niveaux 1 et 2 : pas de créneau, prise en charge en priorité.

Niveaux 3 à 5 : le patient choisit un créneau (**heure fixée**, engagement, e-mail de confirmation) ou reste dans la file (**heure estimée**, pas d'e-mail).

›

Un seul agenda par médecin

On déroule sa journée, consultation après consultation :

1. un **cas prioritaire** (niveau 1 ou 2, demande protégée) passe d'abord et peut décaler un rendez-vous ;
2. un rendez-vous passe à son heure, **jamais avant** ;
3. la file prend les trous qui tiennent avant le prochain rendez-vous (un niveau 3 ne décale jamais un rendez-vous).

›

Exemple : 2 urgences à 9 h 45

Urgences (niveau 2)	**9 h 45**
Amel · fixé 10 h 00	**prévu 10 h 25**
Sami · fixé 10 h 30	**prévu 10 h 45**
Lina · fixé 11 h 00	**prévu 11 h 05**
Youssef · file	**vers 11 h 25**

Consultations de 20 min. Un trou dans l'agenda efface le retard.

›

Les e-mails au patient

- **Rendez-vous confirmé**, modifié ou annulé.
- **Retardé** : seulement si l'heure prévue bouge d'au moins **10 min**, une fois par changement ; « retrouve son heure » au retour.
- Jamais pour une simple estimation de la file.
- **Aucune donnée médicale**, jamais la raison du retard. Une panne d'envoi ne bloque rien.

Les limites à connaître

L'heure prévue est une **estimation** (20 min par consultation) : le système ne sait pas quand le médecin termine, l'administrateur doit mettre à jour le statut. Un ordre de passage ne guérit pas la surcharge : surveiller les demandes « en retard » et réorienter. Horaires des médecins et seuils = valeurs de démonstration, à faire valider par un professionnel de santé.